ICLS救急時計 かんたん操作マニュアル（ブラウザ版）

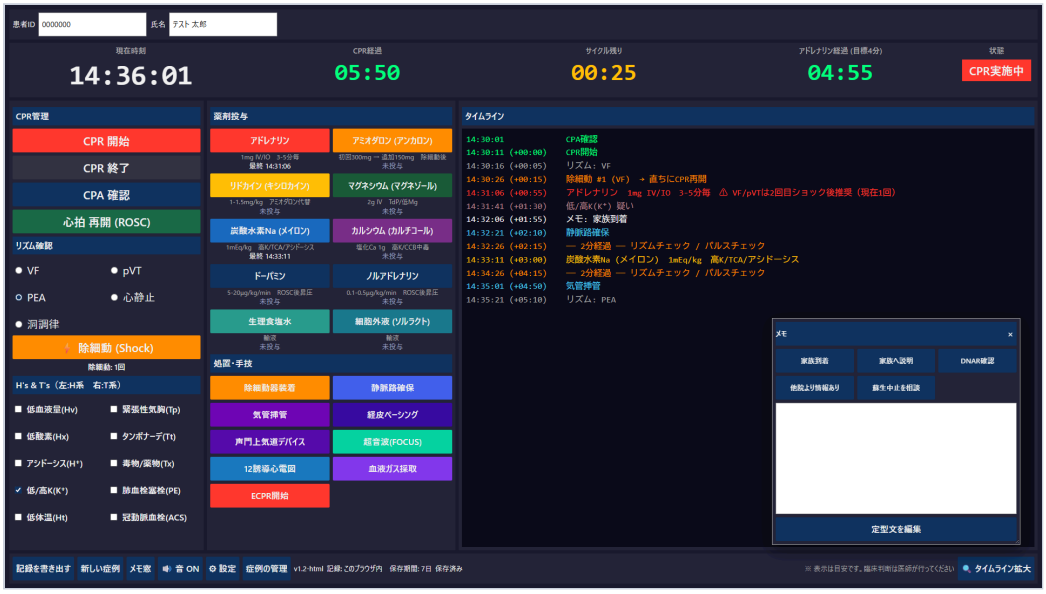
ICLS救急時計 ブラウザ版 v1.2-html（2026-10-09 版）

記録係として動くために必要なことを、この1冊にまとめました。設定の変えかたは載せていません。別冊の「設定ガイド」を見てください。

※ 色で意味を区別している箇所があります。カラーで印刷してください。

画面の見かた

デスクトップの「ICLS救急時計」のアイコンをダブルクリックすると、ブラウザの専用の窓が開いて、この画面が出ます。



左に操作ボタン、中央に薬剤と処置、右にタイムライン（やったことが下に流れます）。右下には小さなメモ窓が出ています。

- 使うブラウザは Microsoft Edge です
- **開いたら、画面のどこかを一度クリックします。** 音声が鳴るようになります。上に「音声を有効にするには…」と出ている間は鳴りません
- 画面を広く使うときは **F11（全画面）** を押します。もう一度押すと戻ります（Edge でも Chrome でも同じです。くわしくは⑦）

---

① 最初に押す：CPR開始

心停止を認識したら、真っ先に「**CPR開始**」（左上の赤いボタン）を押します。これが全部の基準時刻になります。患者IDと氏名は、あとで入れます。空欄のままで始められます。

CPR開始とCPR終了は、セットで使います

押すボタン	いつ押すか	押すとどうなるか
CPR開始	CPRを始めたとき	時計が動き出します。2分ごとの合図も始まります
CPR終了	CPRをやめたとき（中止・終了）	時計が止まります。記録に総時間が残ります。アドレナリンの表示は灰色で止まり、音声も流れなくなります
心拍 再開 (ROSC)	心拍が戻ったとき	**ROSCがCPR終了を兼ねます。** ROSCを押したときは、「CPR終了」は要りません

- CPRをやめたら、必ず「CPR終了」を押します（心拍が戻ったときは「ROSC」）。押し忘れると、時計が動き続け、2分ごとの音声も流れ続けます
- 「CPR開始」の前に「CPR終了」を押しても、何も起きません。画面にも何も出ません
- 「CPR開始」を2回押すと、「CPRはすでに実施中です」と出るだけです。記録は増えません
- いったんやめて再開するときは、もう一度「CPR開始」を押します。CPR経過は0:00から数え直しです

---

② あとは「やったこと」のボタンを押すだけ

やったこと	どこを押すか
心電図の波形を見た	「リズム確認」の VF / pVT / PEA / 心静止 / 洞調律
電気ショックをかけた	「⚡ 除細動 (Shock)」
薬や輸液を入れた	「薬剤投与」の、その薬・輸液のボタン
処置をした（挿管・静脈路確保など）	「処置・手技」の、その処置のボタン
原因を疑った／除外した	「H's & T's」のチェックを入れる・外す
家族の到着など、書き残したいことがある	右下の「メモ」窓
心拍が戻った	「心拍 再開 (ROSC)」

押した瞬間の時刻で、自動的に記録されます。あとから書く必要はありません。迷ったら、まず押して大丈夫です。押し間違えても、あとで取り消せます。

---

③ 4つの時計と色の意味



時計	表すもの
現在時刻	いまの時刻（秒まで）
CPR経過	CPR開始からの経過時間
サイクル残り	次のリズムチェックまでの残り時間（2分ごと）
アドレナリン経過	前回のアドレナリンからの経過時間。目標は初期設定で4分

アドレナリンは「緑のうちに入れる」（目標が4分のとき）

色	経過時間	意味
橙	3:59まで	まだ早い。待つ
緑	**4:00〜5:00**	**いま入れる**
赤	5:01から	遅れている。急ぐ

サイクル残りは「赤くなったら手を止める準備」

色	残り時間	意味
緑	30秒を超える	まだ余裕がある
黄	30秒以下	そろそろ交代の準備
赤	15秒以下	まもなくリズムチェック

> **この2つは、色の意味が逆向きです。** アドレナリンは緑が「いま」、サイクル残りは赤が「もうすぐ」。

声（合成音声。ビープ音ではありません）が、2回流れます。

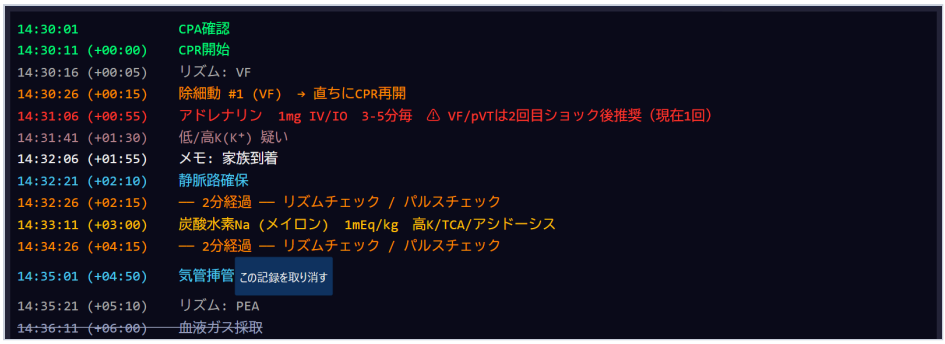
- **2分ごと** … 「リズムチェック」。圧迫者を交代する合図です
- **アドレナリンが目標の時間になったとき** … 「じかん、です」。1回だけ流れます

CPRが終わったあと、心拍が戻ったあとは、アドレナリンの表示が灰色で止まり、音声も流れません。

---

④ 押し間違えたとき

記録の行を**右クリック**して、「この記録を取り消す」を選びます。右クリックを使わないときは、行にカーソルを合わせると出る「この記録を取り消す」ボタンを押します。カーソルのない端末（タブレットなど）では、このボタンが最初から出ています。



- 取り消した行は消えず、**打消線**が付いて残ります。あとから見返せます
- カルテに貼るときは、取り消した行は自動で除かれます
- 間違えて取り消したときは、同じ行の「取消を戻す」で戻せます
- **アドレナリンを取り消すと、その前の投与が基準に戻ります。**取り消した投与は「前回の投与」に数えません

---

⑤ メモの使いかた



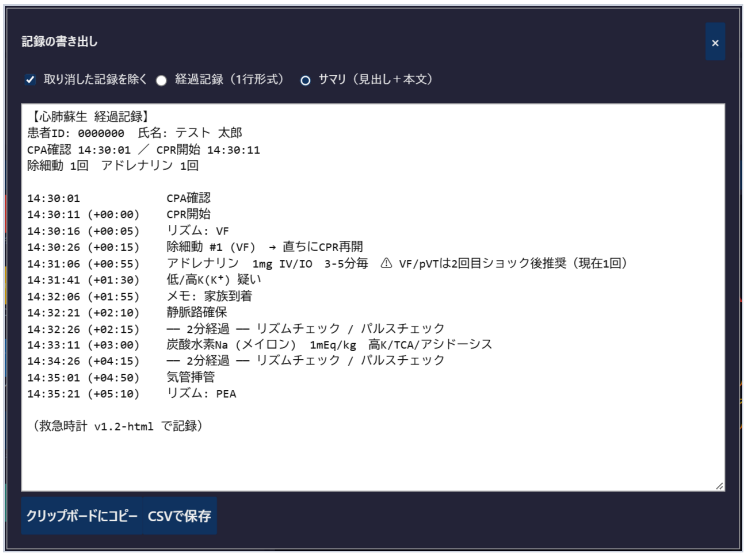
- **定型文のボタン** … 押すだけで記録されます。確認は出ません（定型文を変えるときは、設定ガイドを見ます）
- **自由に書く** … 下の欄に打って **Enter** を押すと記録されます。改行は **Shift + Enter**
- 日本語を変換しているときの Enter は、変換の確定です。**確定してから、もう一度 Enter を押すと記録されます**

メモは、薬や処置と同じ時系列に並びます。カルテに貼ると、経過とメモが1本の記録になります。

メモ窓は、上の青い帯をドラッグして動かせます。右上の × で閉じても、下部の「メモ窓」ボタンで開き直せます。画面が小さいとき（ブラウザを拡大表示しているときなど）は、最初は閉じています。

---

⑥ 記録を終えて、カルテに貼るまで



1. 落ち着いたら、上の欄に**患者ID・氏名**を入れます（あとから入れても、それ以前の記録すべてに付きます）
2. 下部の「**記録を書き出す**」を押します
3. 形式を選びます
   - **経過記録** … カルテの経過欄に貼れる、1行ずつの形式
   - **サマリ** … 冒頭にCPR時間や除細動の回数などの要点、その下に経過が続く形式
4. プレビューは書き直せます。コピーされるのは、書き直したあとの内容です
5. 「**クリップボードにコピー**」を押して、カルテに貼り付けます
6. 表計算ソフトで使うときは「CSVで保存」を押します（保存先を選ぶ画面が出ます）

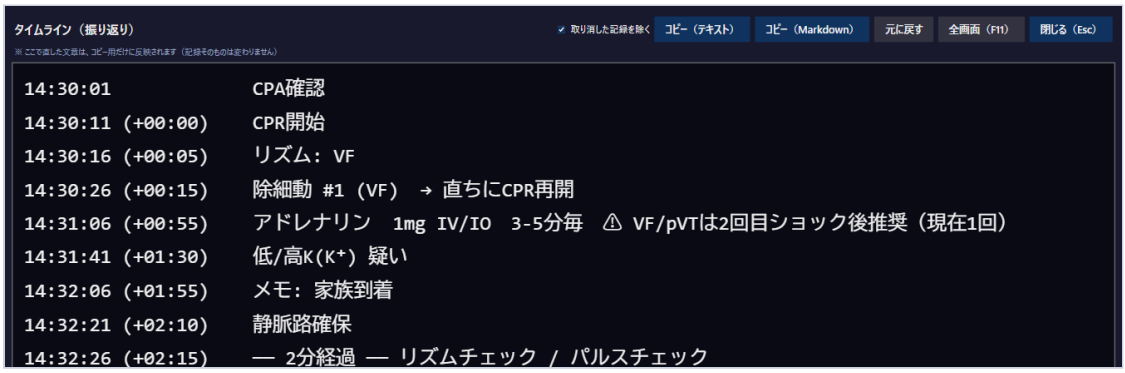
---

⑦ 終わったあとに振り返る：タイムラインを大きく見る（v1.2 の新機能）

シナリオやCPRが終わったあと、**やったことの流れ（タイムライン）だけを、画面いっぱいに大きく出せます。**振り返りや、みんなで見るときに使います。



1. 画面の下の列にある「🔍 **タイムライン拡大**」を押します
2. タイムラインだけが、大きな文字で画面いっぱいに出ます



上の列のボタンで、次のことができます。

ボタン	できること
コピー（テキスト）	いま出ている文章を、そのままコピーします。メモ帳やカルテに貼れます
コピー（Markdown）	見出しと表（時刻｜経過｜内容）の形にしてコピーします。報告書や資料に貼るときに使います
元に戻す	直した文章を捨てて、記録のとおりに作り直します
取り消した記録を除く	初期は入っています（取り消した記録は出ません）。外すと、取り消した記録も「【取消】」つきで出ます

ボタン	できること
全画面（F11）	ブラウザごと全画面にします（下の「全画面にする・戻す」）。もう一度押すと戻ります
閉じる（Esc）	元の画面に戻ります。Esc キーでも戻れます

文章は、メモ帳のように直せます。 画面の文章をクリックして、書き足したり消したりします。

- **直した内容は、コピー用の文章にだけ反映されます。保存された記録そのものは変わりません。** 記録の書き出し（⑥）にも出ません
- 直しているあいだは、Esc キーでは閉じません（直した文章が消えてしまうため）。閉じるときは「閉じる」ボタンを押します
- 開き直すたびに、最新の記録から作り直します。直した文章は残りません。必要なら、閉じる前にコピーしてください

使うときの注意

- CPRの最中には押さないでください。時計が見えなくなります。終わってから使います
- 時計は裏で動き続けています。2分ごとの声も出ます

全画面にする・戻す（F11）

画面を広く使いたいとき、また振り返りで大きく映したいときは、ブラウザを全画面にします。

操作	やりかた
全画面にする	キーボードの **F11** を押す（Microsoft Edge も Google Chrome も同じ）。または、タイムライン拡大の「全画面（F11）」ボタン
元に戻す	もう一度 **F11** を押す（ボタンから全画面にしたときは、**Esc** でも戻れます）
文字をもっと大きくする	**Ctrl** を押しながら ＋（小さくするときは **Ctrl** ＋ −、元の大きさは **Ctrl** ＋ **0**）

- 「ICLS救急時計」のアイコンから開いた専用の窓でも、F11 は同じように使えます
- ノートパソコンで F11 が効かないときは、**Fn** キーを押しながら F11 を押します

---

⑧ 次の患者さんが来たら

カルテへの貼り付けが終わってから、「新しい症例」を押します。画面が新しくなります。前の患者さんの記録は、このパソコンのブラウザの中に残っています（⑩）。

---

⑨ 画面を閉じてしまった・パソコンが止まったとき

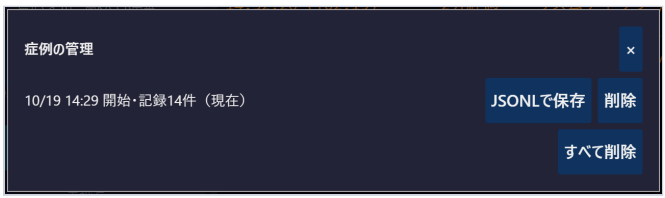
もう一度開くと、「前回の記録が残っています。続きから開きますか？」と出ます。「**はい**」を押すと、記録も時計も元どおりになります。

CPR中に画面を閉じたり更新したりしようとすると、確認が出ます。「キャンセル」を押せば、そのまま続けられます。

---

⑩ 記録の置き場所と、消えるとき

- 記録は、**いま使っているパソコンの、このブラウザの中**に保存されます。画面下に「記録: このブラウザ内」と出ています
- **別のパソコンや、別のブラウザ（EdgeとChromeなど）からは見えません**
- 保存期間（初期値7日）を過ぎた記録は、次に開いたときに自動で消えます
- 下部の「症例の管理」で、残っている記録を見られます。控えを書き出す（JSONLで保存）、1件を消す（削除）、全部消す（すべて削除）もここでします。削除は**元に戻せません**



- **共用のパソコンでは、使い終わった症例を「削除」します。** 次に使う人に、患者さんの情報が見えてしまいます
- ブラウザの「閲覧データの削除」でサイトデータを消すと、記録も一緒に消えます

困ったとき

こうなった	こうする
CPRをやめたのに、時計が動き続けて、2分ごとの音声も流れる	「CPR終了」（心拍が戻ったときは「ROSC」）の押し忘れです。いま押せば止まります。押した時刻が終了の時刻になります
音声が鳴らない	画面のどこかを一度クリックします。それでも鳴らなければ、責任者に伝えます（声の選びかたは設定ガイド）
上に「日本語の音声が見つかりません」と出た	音声の代わりに、ビープ音が鳴ります（2分ごとは短く2回、アドレナリンは短く3回）。そのまま使えます
音を止めたい	下部の「音」を押して、OFFにします
メモ窓が消えた	下部の「メモ窓」を押します
「すでに別のタブで開いています」と出た	すでに開いている救急時計の画面を使います。見つからないときは、ブラウザをすべて閉じて、開き直します
上に赤く「記録を保存できません」と出た	**この画面を閉じると、記録が失われます。**「記録を書き出す」でコピーして控えを取り、責任者に伝えます。プライベートウィンドウ（InPrivate・シークレット）で開いていないかも確かめます
患者IDを入れ忘れた	「記録を書き出す」を押す前なら、いつでも入れられます
定型文を変えたい	責任者に相談します（設定ガイド）

やってはいけないこと

- **複数人で同時に押す** … 記録が二重になります。記録係は1人にします
- **貼り付ける前に「新しい症例」を押す** … 画面の表示が消えます（記録は「症例の管理」に残りますが、手間が増えます）
- **プライベートウィンドウ（InPrivate・シークレット）で使う** … 閉じると、記録が消えます
- **EdgeとChromeを両方開いて、それぞれで使う** … 記録が別々になり、二重の起動も防げません。使うブラウザは1つに決めます
- **終わった症例を、共用パソコンに残す** … ⑩のとおり、削除します

※ 表示される用量とタイミングは目安です。臨床判断は、必ず医師が行います。※ 記録の正本は診療録です。このツールの出力は、補助資料として扱います。

用語集（裏面）

略語

略語	読み	意味
CPA	シーピーエー	心肺停止。心臓も呼吸も止まっている状態
CPR	シーピーアール	心肺蘇生。胸骨圧迫と人工呼吸
ROSC	ロスク	自己心拍再開。蘇生がいったん成功した状態
VF	ブイエフ	心室細動。電気ショックが効く波形
pVT	ピーブイティー	無脈性心室頻拍。これも電気ショックが効く波形
PEA	ピーイーエー	無脈性電気活動。波形はあるのに脈が触れない。ショックは効かない
心静止	asystole	心電図が平坦な状態。ショックは効かない
除細動	じょさいどう	電気ショックのこと。VF・pVTのときだけ行う

H's & T's（見つけて治せる原因）

心停止には、見つけて治せる原因が10個あります。頭文字がHとTなので、こう呼ばれます。疑わしいものにチェックを入れると「疑い」、外すと「除外」として記録されます。

H系（左側）	内容	T系（右側）	内容
低血液量(Hv)	出血や脱水で、血が足りない	緊張性気胸(Tp)	肺から空気が漏れて、圧迫している
低酸素(Hx)	酸素が足りない	タンポナーデ(Tt)	心臓の周りに、水や血が溜まっている
アシドーシス(H^+)	体が酸性に傾いている	毒物/薬物(Tx)	薬や毒物による中毒
低/高K(K^+)	血液中のカリウムの異常	肺血栓塞栓(PE)	肺の血管が、血の塊で詰まっている
低体温(Ht)	体温が下がりすぎている	冠動脈血栓(ACS)	心臓の血管が詰まっている（心筋梗塞）

ボタンの並び

下の列 … 記録を書き出す／新しい症例／メモ窓／音 ON・OFF／設定／症例の管理／**タイムライン拡大**（v1.2）

薬剤投与（10個） … アドレナリン／アミオダロン（アンカロン）／リドカイン（キシロカイン）／マグネシウム（マグネゾール）／炭酸水素Na（メイロン）／カルシウム（カルチコール）／ドーパミン／ノルアドレナリン／生理食塩水／細胞外液（ソルラクト）

処置・手技（9個） … 除細動器装着／静脈路確保／気管挿管／経皮ペーシング／声門上気道デバイス／超音波(FOCUS)／12誘導心電図／血液ガス採取／ECPR開始

薬剤のボタンの下に、用量の目安が小さく書いてあります。投与量の計算はしません。表示は目安です。

個人情報の取り扱い

このアプリは、患者ID・氏名を記録します。記録は、このパソコンのブラウザの中に保存され、インターネットには送られません（外部との通信はしません）。

- 記録の正本は診療録です。アプリの記録は補助資料として扱います
- 保存期間（初期値7日）を過ぎた記録は、自動で消えます。共用のパソコンでは、終わった症例を「症例の管理」から削除します
- 「JSONLで保存」「CSVで保存」で作ったファイルにも、患者さんの情報が入っています。ダウンロードしたフォルダに置いたままにせず、決められた場所で扱い、不要になったら削除します
- 端末の運用ルールに従います。保存期間や削除の判断は、所属部署の取り決めに合わせます

困ったこと、分からないことがあれば、一人で悩まず、上司やシステム責任者に確認してください。